TÓM TẮT LÝ THUYẾT · TAI - MŨI - HỌNG

BÀI 4 Viêm tai giữa

Tóm tắt từ bài giảng 4. VIEM TAI GIUA.pdf (67 trang) · Giữ ý chính và số liệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. GIẢI PHẪU TAI GIỮA
2. ĐỊNH NGHĨA
3. VIÊM TAI GIỮA CẤP
4. VIÊM TAI GIỮA MẠN TÍNH

1. GIẢI PHẪU TAI GIỮA

- Tai gồm **tai ngoài** (loa tai, ống tai ngoài), **tai giữa** (hòm nhĩ, 3 xương con, vòi nhĩ, xương chũm), **tai trong** (mê đạo xương, mê đạo màng).
- Tai giữa liên quan **vòm mũi họng** (qua vòi nhĩ – nguồn **nguyên nhân**) và **xương chũm** (nơi xảy ra **biến chứng**).
- **Hòm nhĩ:** hốc rỗng như cái trống, theo mặt phẳng đứng dọc, chếch trước – sau; đường kính đứng **15 mm**, trước sau **15 mm**, ngang: trên 6 mm, **giữa 2 mm**, dưới 4 mm; gồm hòm nhĩ chính và **ngách thượng nhĩ**.

Thành	Đặc điểm
Trên	**Trần hòm nhĩ**
Dưới	**Thành tĩnh mạch** – mảnh xương mỏng ngăn với lỗ TM cảnh
Trước	**Thành động mạch** – ống cơ căng màng nhĩ ở trên, **vòi nhĩ** ở dưới; ngăn với **ĐM cảnh trong**
Sau	**Thành chũm** – rộng trên, hẹp dưới; có lỗ thông hang
Trong	**Thành mê đạo** – **ụ nhô**, cửa sổ tiền đình, cửa sổ ốc tai, lồi ống TK mặt, lồi ống bán khuyên ngoài
Ngoài	**Màng nhĩ**

- **Màng nhĩ:** hình bầu dục, mỏng, **màu xám nhạt**; đường kính lớn 9 – 10 mm, nhỏ 8 – 9 mm; có **phần chùng** (trên), **phần căng**, nếp búa trước – sau, **nón sáng**.
- **Xương con: búa** (chỏm, cổ, cán), **đe** (thân, trụ ngắn, trụ dài), **bàn đạp**.
- **Vòi nhĩ:** thông với hầu qua lỗ hầu vòi tai; dài **37 mm**; **1/3 xương (12 mm)**, **2/3 sụn (24 – 25 mm)**; chỗ nối xương – sụn là **eo vòi – hẹp nhất**; vận động bởi **cơ căng màn hầu, cơ nâng màn hầu**.
- **Xương chũm:** thông với ngách thượng nhĩ qua **lỗ thông hang (sào đạo)**.
- **Mạch máu – thần kinh:** ĐM hàm trên, tai sau, hầu lên, màng não giữa, cảnh trong; giao cảm qua **đám rối hòm nhĩ (TK lưỡi hầu)**; bạch huyết về **hạch cổ sâu trên, hạch mang tai**.

2. ĐỊNH NGHĨA

- Viêm tai giữa (VTG) là **viêm niêm mạc tai giữa**, cấp hoặc mạn, do nhiều nguyên nhân, **nhất là ở trẻ em**.
- Điều trị không triệt để → **mạn tính**, ảnh hưởng nhiều **chức năng nghe**.

3. VIÊM TAI GIỮA CẤP

VTG cấp xuất tiết dịch thấm

- Nguyên nhân: **u vòm**, **mất thăng bằng áp lực**, **dị ứng**.
- Triệu chứng: đau tai, **ù tai giọng trầm**, **điếc dẫn truyền nhẹ, giảm khi nuốt hoặc xì mũi**.

- Điều trị: **đưa không khí vào hòm tai**, kháng viêm, kháng dị ứng. Phòng: **xì mũi từng bên**, không đi máy bay, bơi lội khi viêm mũi xoang, làm **Valsalva**.

VTG cấp xung huyết

- Nguyên nhân: viêm vòm mũi họng, **V.A**, viêm mũi xoang cấp (cảm).
- **Triệu chứng chính: đau tai**; ù tai, điếc thường không có hoặc rất ít.
- Màng nhĩ **hồng hơn bình thường**, **mạch máu giãn đỏ dọc cán búa**, lõm nhẹ; dịch ít nên **không thấy mức nước**; có thể chuyển thành VTG mủ.
- Điều trị: giảm đau, đưa không khí vào tai; nguyên nhân: **nạo V.A**, điều trị viêm mũi xoang.

VTG cấp mủ

- Nguyên nhân: viêm vòm, V.A, u vòm, viêm xoang, **đặt meche mũi để lâu**, **cúm, sởi**, rách màng nhĩ do chấn thương.
- Vi khuẩn: **Streptococcus, Pneumococcus, Staphylococcus, Proteus**.
- **Giai đoạn đầu:** sổ mũi, ngạt mũi, sốt, đau tai, **màng nhĩ sung huyết**.
- **Toàn phát – màng nhĩ chưa vỡ: đau tăng theo nhịp đập**, điếc, ù tai, tự thính, chóng mặt.
- **Màng nhĩ đã vỡ:** triệu chứng toàn thân **giảm nhanh**; tự vỡ thì lỗ thủng **nhỏ và trên cao**.
- **Biến chứng cấp: viêm xương chũm cấp**, viêm mê nhĩ, **liệt VII**, nội sọ. **Kéo dài:** gián đoạn màng nhĩ – xương con, **xơ nhĩ**.

Các thể lâm sàng

- **Trẻ sơ sinh:** vòi nhĩ ngắn, thượng nhĩ còn **gélatin**; thể suy yếu dễ biến chứng **viêm xương chũm cấp**.
- **Trẻ em:** triệu chứng **ồ ạt**, sau **cúm, sởi**. **Người già:** không điển hình, dựa vào **đau và giảm thính lực**.
- **Thể khu trú:** viêm **túi Troltsch** (thượng nhĩ trong), viêm **túi Prussak** (thượng nhĩ ngoài).
- Do bệnh nhiễm trùng nặng: thường **hủy hoại màng nhĩ – xương con**; do **Pneumococcus mucosus**: **âm thầm, hay gây viêm xương chũm**.

Nguyên tắc "3 không": không bỏ sót (bị che lấp bởi triệu chứng toàn thân); **không nhầm** với chàm ống tai ngoài, **zona tai**, nhọt ống tai, viêm màng nhĩ đơn thuần; **không nhầm với VTG mạn hồi viêm**.

Điều trị: nội khoa (giảm đau, kháng sinh). **Chích rạch màng nhĩ** khi: toàn thân xấu (**sốt, nôn, ỉa chảy**), cơ năng quá rõ, **màng nhĩ phồng**, có dấu gợi ý biến chứng.

Phòng bệnh: xì mũi đúng cách, không bơi lặn khi viêm mũi xoang, điều trị viêm xoang, **nạo V.A, cắt amidan**, phòng bội nhiễm khi cúm, sởi.

4. VIÊM TAI GIỮA MẠN TÍNH

Thể	Đặc điểm chính	Điều trị
Mạn xuất tiết – xơ nhĩ	Hậu quả **VTG xuất tiết nhiều lần**; niêm mạc **thoái hóa trong, vôi hóa**. **Điếc dẫn truyền là chủ yếu**, dao động, tiến triển; **Valsalva (–)**; nhĩ đồ nhiều đỉnh, lệch âm hoặc **dạng bẹt**	Nguyên nhân (lấy u vòm, nạo V.A, điều trị viêm xoang) + **gỡ xơ, vá nhĩ, tạo hình xương con**
Mạn xuất tiết nhầy mủ	Nguyên nhân ở **vòm, mũi xoang**; bệnh tích ở thượng nhĩ, sào bào, vòi. **Chảy tai là chủ yếu**, tăng khi viêm mũi xoang, dịch **nhầy mủ, không hôi**. Lỗ thủng **góc trước – dưới, nhỏ, tròn, cách khung nhĩ 1 mm**; điếc dẫn truyền nhẹ; CT: xương chũm kém thông bào, **không viêm xương**	Nguyên nhân (vòm, mũi xoang) + phẫu thuật bệnh tích thượng nhĩ – sào bào

Thể	Đặc điểm chính	Điều trị
Mủ mạn	Bệnh tích tai giữa **kèm bệnh tích xương** (viêm xương, **cholesteatoma**). Nguyên nhân: VTG cấp điều trị sai, **đề kháng kém** (lao, tiểu đường, sau xạ), độc lực VK mạnh. **Mủ đặc, hôi**; đau chỉ khi hồi viêm; điếc dẫn truyền → **tiếp nhận**; CT: **viêm, hủy xương**	Phẫu thuật

- Các thể của VTG nhầy mủ: **viêm tai do vòi**, viêm tai màng nhĩ đóng kín, **viêm tai keo**.
- **Biến chứng VTG mủ mạn:** cục bộ – **viêm hủy xương chũm**, **liệt VII**, **viêm xương chũm cấp**, **xơ nhĩ**; xa – **xương thái dương**, **nội sọ**.
- **Phẫu thuật VTG mủ mạn:**
  - **Điều trị viêm: khoét chũm tiệt căn**, khoét chũm tiệt căn cải biên.
  - **Phục hồi chức năng: tạo hình tai giữa**, **vá nhĩ**, gỡ xơ dính, **tạo hình xương con**.
- **Quá trình bệnh: tắc vòi (V.A, xoang, u)** → viêm tai thanh dịch → viêm tai nhầy → **xẹp nhĩ** (toàn bộ / khu trú) → **cholesteatoma**. Can thiệp: **ống thông khí**, chỉnh hình hòm nhĩ, khoét chũm tiệt căn mini.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế bài giảng gốc. Đối chiếu 4. VIEM TAI GIUA.pdf khi cần chi tiết.